

RETRECISSEMENT AORTIQUE

Pr. RABEARIVONY Nirina

Cardiologue

Introduction

- **Définition:**
 - **obstruction a l'éjection systolique du ventricule gauche localisée au niveau de la valve aortique.**
- **Intérêts:**
 - **valvulopathie la plus fréquente chez les sujets âgés**

I) Physiopathologie

- RA → gradient de P° systolique entre VG - AO, proportionnel au degré de la sténose
- Surface AO normale = 3 à 4 cm²
- RA modérément serré = 1 à 2 cm²
→ gradient = 50 à 60 mmHg
- RA serré < 0,75 cm² → gradient > 80 mmHg

I) Physiopathologie

I.1- Conséquences en amont:

- RA → surcharge de pression VG

→ ↗ P° télédiastolique VG

→ hypertrophie myocardique

→ réduction de la cavité VG

} ↓ distensibilité VG

→ ↗ P° OG → HTAP

I) Physiopathologie

I.2- Conséquences en aval:

I.21- débit cardiaque

- normal au repos
- ne s'adapte pas à l'effort (orifice AO réduite)
→ **syncope d'effort**

I.22- circulation coronaire

- retard de l'élévation de PA systolique AO
→ baisse perfusion coron. systolique
- ↗ PTDVG
→ gêne perfusion coron. diastolique

→ **angor d'effort**

II) Anatomico-pathologie

II.1- RA dégénératif

- valves rigides, indurées, très calcifiées
- commissures atteintes par le processus fibreux et calcifiant
- calcification de l'anneau s'étendant vers le SIV



II) Anatomico-pathologie

II.2- RA rhumatismal

- symphyse commissurale
- épaississement fibreux et rétractile des valves
- calcification tardive

II.3- RA congénital

- orifice à suture tricommissurale
ou
- orifice bicuspidé secondairement rétréci par
des calcifications

III) Signes

III.1- Type de description: RA serré dégénératif du sujet âgé

III.11- Circonstances de découverte

- fortuite chez un sujet > 70 ans → souffle
- devant des signes d'appel (syncope d'effort, angor d'effort, dyspnée,....)
- lors d'une complication (IC, BAV,...)

III) Signes

III.1- Type de description: RA serré dégénératif du sujet âgé

III.12- Clinique

III.121- auscultation

- souffle systolique (éjectionnel)
- 2^e EIC Droit
- irradiant vers les vaisseaux du cou et l'apex (**souffle en écharpe**)
- rude, « serratique » (bruit de la scie)
- intensité 3 à 4/6 (pas de parallélisme entre intensité du souffle et degré du RA)
- abolition de B2
- galop présystolique (B4)

III) Signes

III.1- Type de description: RA serré dégénératif du sujet âgé

III.12- Clinique

III.121- Palpation

- frémissement systolique au foyer AO

III.122- Signes périphériques

- pouls petit et retardé
- PAS basse → PA différentielle pincée

III) Signes

III.1- Type de description: RA serré dégénératif du sujet âgé

III.13- Radiologie:

- calcifications valvulaires
- déroulement et dilatation de l'AO ascendante (« lésion de jet »)
- augmentation de l'arc inf. gauche (tardive)

III) Signes

III.1- Type de description: RA serré dégénératif du sujet âgé

III.14- ECG

III.131- HVG

- axe QRS dévié à Gauche
- indice de Sokolow > 35 mm
- trouble secondaire de la repolarisation (sous-décal. de ST et $T < 0$ asymétrique)

III.132- Troubles de la conduction

- Big ou BBG
- BAV 1

III) Signes

III.1- Type de description: RA serré dégénératif du sujet âgé

III.15- Echodoppler cardiaque

III.151- Echo 2D et TM

- valves aortiques épaissies
- ouverture valvulaire réduite en systole
- hypertrophie pariétale du VG

III.152- Doppler

- évalue le gradient transvalvulaire

III) Signes

III.1- Type de description: RA serré dégénératif du sujet âgé

III.16- Evolution:

- pronostic spontané = grave
- survie après apparition de:
 - angor ou syncope = 4 à 5 ans
 - dyspnée ou OAP = 1 à 2 ans

III.17- Complications:

- embolie calcaire → AVC, amaurose
- EI (rare)
- BAV
- mort subite (25%)

III) Signes

III.2- Formes cliniques

III.21- Formes évolutives

III.211- RA asymptomatique

- longtemps bien toléré (surveillance++)
- risque de mort subite = faible (1%)

III.212 - RA symptomatique

- pronostic grave

III.22- Formes selon le terrain

- adulte = RA acquis
- enfant = toujours congénital

III) Signes

III.2- Formes cliniques

III.21- Formes associées:

- RA + IA = maladie aortique
- RA + RM
- RA + IM

IV) Diagnostic

IV.1- Positif:

- repose sur le souffle systolique « en écharpe »
- confirmé par l'échodoppler

IV. 2- Différentiel:

- IM par rupture de cordages
 - SS max au foyer AO, irradiation ascendante
- CM hypertrophique obstructive (CMHO)

IV) Diagnostic

IV.3- Etiologique

IV.31- RA acquis

IV.311- Dégénératif (Mdie de Mönckeberg)

- la plus fréquente après 65 ans
- calcification +++

IV.312- Rhumatismal

- rare

IV.32- RA congénital

- valvulaire (sur bicuspidie +++)
- sus ou sous-valvulaire

V) Traitement

V.1- Moyens:

V.11- Médical:

Il est limité :

- tonicardiaques (digitaliques, dobutamine...):
sont contre-indiqués
- vasodilatateurs doivent être utilisés à petites doses (risque de collapsus)
- diurétiques (utiles en cas de dyspnée)
- prévention de l'endocardite infectieuse

V) Traitement

V.1- Moyens:

V.11- Chirurgical

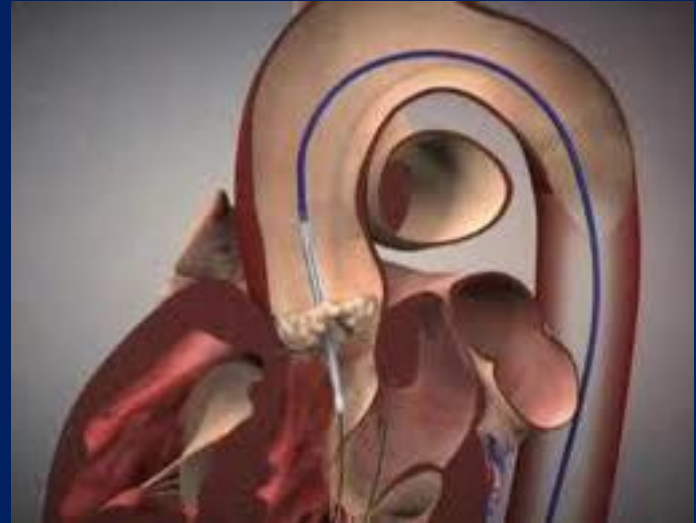
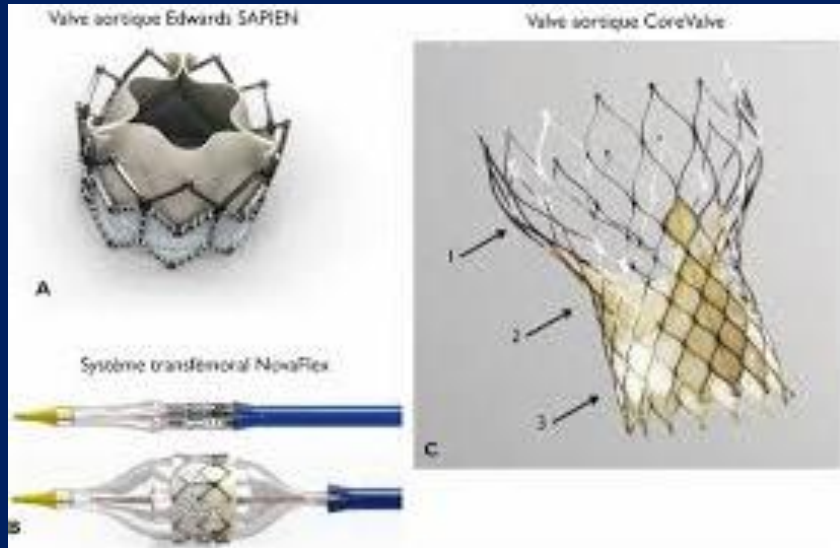
V.111- Implantation valvulaire aortique percutanée (TAVI)

- mise en place d'une prothèse aortique par voie fémorale

V.112- Valvuloplastie aortique percutanée

- dilatation du RA par un ballon à l'extrémité d'un cathéter
- abandonnée car resténose +++

V) Traitement



Transcatheter Aortic Valve Implantation

V) Traitement

V.1- Moyens:

V.11- Chirurgical

V.12- Remplacement valvulaire AO sous CEC

- bioprothèse**
- prothèse mécanique**

V) Traitement

V.2- Indications:

V.21- RA symptomatique

- Tout RA serré symptomatique doit être opéré, sans limite d'âge (si bon état général et sans autre pathologie mettant en jeu le pronostic vital a court terme)

V.22- RA asymptomatique

- RA serré + HVG → intervention
- autres cas → pas d'intervention, surveillance++